

Evaluation : les infections urinaires

1. **Une infection urinaire est dite à risque de complication si :**
 - A- Elle survient chez la femme
 - B- Uropathie malformative
 - C- Grossesse
 - D- Elle survient chez un patient ayant eu une résection endoscopique de tumeur vésicale
 - E- Elle survient chez un patient âgé de plus de 50 ans
2. **Un sujet jeune ayant une pyélonéphrite aiguë lithiasique obstructive avec un rein controlatéral normal, l'attitude immédiate doit comporter :**
 - A- Traitement ambulatoire
 - B- Hospitalisation
 - C- Antibiothérapie probabiliste visant les Cocci Gram +
 - D- Drainage des voies excrétrices
 - E- Antibiothérapie contre les BGN
3. **Une infection urinaire est considérée à risque de complication dans les situations suivantes :**
 - A- Age à 75 ans
 - B- Diabète
 - C- Reflux vésico-urétéral
 - D- Grossesse
 - E- Insuffisance rénale chronique
4. **Quel est l'examen d'imagerie le plus sensible pour l'étude morphologique de l'arbre urinaire :**
 - A- Arbre urinaire sans préparation
 - B- Echographie
 - C- Scintigraphie
 - D- Urétrocystographie rétrograde
 - E- Uroscanner
5. **Les bactéries suivantes réduisent les nitrates en nitrites :**
 - A- *Enterococcus faecalis*
 - B- *Escherichia coli*
 - C- *Proteus mirabilis*
 - D- *Pseudomonas aeruginosa*
 - E- *Staphylococcus saprophyticus*
6. **Parmi les anomalies suivantes, laquelle confirme le diagnostic d'une infection urinaire :**
 - A- Aspect trouble des urines
 - B- Uroculture positive
 - C- Hématurie
 - D- Leucocyturie $> 100/\text{mm}^3$
 - E- Nitrites positifs à la BU

7. **Quel est l'antibiotique à utiliser en première intention chez une femme de 80 ans ayant une cystite aigue :**
- A- Amoxicilline - Acide clavulanique
 - B- Ciprofloxacine
 - C- Cotrimoxazole
 - D- Fosfomycine trométamol
 - E- Furadoïne
8. **La durée du traitement d'une prostatite aigue chez un homme de 68 ans, ayant une hypertrophie bénigne de la prostate est de :**
- A- 10 jours
 - B- 14 jours
 - C- 3 semaines
 - D- 4 semaines
 - E- 6 semaines
9. **Le traitement de première intention d'une pyélonéphrite aigue communautaire grave est :**
- A- Amoxicilline - Acide clavulanique + Gentamycine
 - B- Céfotaxime + Ciprofloxacine
 - C- Céfotaxime
 - D- Céfotaxime + Amikacine
 - E- Ofloxacine
10. **Les bandelettes urinaires :**
- A- constituent l'examen de confirmation de l'infection urinaire
 - B- sont recommandés pour le diagnostic d'une cystite aigue simple
 - C- mettent en évidence des nitrites en cas d'infection urinaire à *S. saprophyticus*
 - D- ont une forte valeur prédictive positive chez l'homme
 - E- permettent d'éliminer une infection urinaire chez la femme
11. **Les germes suivants sont responsables des infections urinaires communautaires :**
- A- *Staphylococcus aureus*
 - B- *Enterobacter spp*
 - C- *Klebsiella pneumoniae*
 - D- *Pseudomonas aeruginosa*
 - E- *Escherichia coli*
12. **Les antibiotiques pouvant être prescrits chez une femme enceinte présentant une infection urinaire quel que soit le terme :**
- A- Gentamycine
 - B- Cotrimoxazole
 - C- Céfixime
 - D- Ceftriaxone
 - E- Ciprofloxacine

13. Une femme de 30 ans consulte pour un 5ème épisode d'infection urinaire en 8 mois. Quels conseils hygiéno-diététiques vous lui prodiguez pour éviter les récurrences :

- A- Mictions régulières
- B- Régularisation du transit intestinal
- C- Traitement des infections génitales basses
- D- Diurèse suffisante
- E- Abstinence si le rapport sexuel est un facteur déclenchant

QROC :

1. Citer 4 facteurs favorisant l'infection urinaire chez la femme enceinte :

-
-
-
-

2. Quelle est la principale voie de contamination de l'appareil urinaire lors de l'infection urinaire ?

-

3. Citez 4 conditions pour considérer qu'une cystite aigue est simple :

-
-
-
-

4. Citez 4 étiologies d'une leucocyturie avec culture négative :

-
-
-
-
-

5. Quelle est l'indication d'un traitement minute dans les infections urinaires ? Et quelle est la molécule utilisée ?

-
-

6. Citez 4 complications de la prostatite aigue.

-
-
-

-
- 7. Citer les indications de dépistage et de traitement d'une colonisation urinaire :
 -
 -
- 8. Quels sont les indications d'une bithérapie en cas d'infections urinaires :
 -
 -
- 9. Quel est la durée de traitement de la cystite et la pyélonéphrite chez l'enfant :
 -
 -

Cas clinique 1 :

Patient âgé de 17 ans, aux antécédents d'infections urinaires récidivantes, consulte pour une fièvre associée à des douleurs lombaires évoluant depuis 2 jours. Au bilan :

NFS: Hb= 12 g/dL; GB = 12500/mm³ ; Plaq = 165 000/ mm³ ; CRP = 255 mg/L ; Créat = 350 μmol/L

L'examen cytot bactériologique des urines avait mis en évidence une leucocyturie à 1500/mm³ et avait isolé *Escherichia coli*.

L'échographie abdominale : dilatation urétéro-pyélocalicielle bilatérale sans image d'obstacle, Prostate de taille normale.

Le diagnostic d'une pyélonéphrite aiguë à risque de complication était retenu.

1. Quels sont les deux éléments en faveur du caractère compliqué de cette pyélonéphrite aiguë ?

-
-

2. Quelle est votre conduite thérapeutique de première intention? (Molécule)

-

3. Que suspectez vous devant ces infections urinaires récidivantes ?

-

4. Quels examens complémentaires demandez vous à distance de cet épisode ?

-

Cas clinique 2 :

Patiente âgée de 28 ans, sans antécédents pathologiques, consulte pour brûlures mictionnelles avec une fièvre et douleurs lombaires droite évoluant depuis 3 jours. Elle est institutrice et enceinte à 7 semaines d'aménorrhée (première grossesse). L'examen physique était normal hormis une fièvre à 38,1°C et une douleur à la palpation de la fosse lombaire droite.

ECBU: leucocyturie à 600/mm³ ; Hématies < 1/mm³. Vous évoquez le diagnostic de pyélonéphrite aiguë. L'échographie abdominale avait montré une grossesse monofœtale évolutive.

1. Faut-il hospitaliser cette patiente ? Justifiez votre réponse

-

2. Quelle antibiothérapie de première intention prescrivez-vous (Molécules/ Voies d'administration) ?

L'évolution était favorable.

3. Comment faut-il surveiller cette patiente ?

A 35 semaines d'aménorrhée, l'ECBU avait montré $L = 100/\text{mm}^3$; $H < 1/\text{mm}^3$; culture positive à *Escherichia coli* de phénotype sauvage. La patiente n'a aucune plainte fonctionnelle et l'examen physique est normal.

4. Quel est votre diagnostic ?

5. Faut-il traiter cette patiente ? Si oui, justifiez votre réponse et quelle antibiothérapie lui prescrivez-vous ?

Cas clinique 3 :

Un patient âgé de 70 ans, diabétique type 2 sous metformine, consulte pour brûlures mictionnelles avec dysurie et fièvre évoluant depuis 48 heures.

A l'examen, GSG = 15/15 ; TA = 120/70 mmHg ; Fc = 96 bpm ; FR = 24 c/min ; $T^\circ = 39,8^\circ\text{C}$.
Au toucher rectal, prostate hypertrophiée douloureuse à la pression.

G/A = +++/++ ; Glycémie = 16 mmol/L ; Créat = 285 $\mu\text{mol/L}$; Urée = 15 mmol/L ; $\text{Na}^+ = 130 \text{ mmol/L}$; $\text{K}^+ = 5,2 \text{ mmol/L}$; GB = 18000/ mm^3 ; Hb = 11,7 g/dL ; Plaq = 145000/ mm^3

1. Quel est le premier diagnostic à évoquer ?

2. Quels sont les deux examens bactériologiques à demander chez ce patient ?

3. Faut-il hospitaliser ce patient ? Justifier votre réponse.

4. L'acte à proscrire chez ce malade est :

5. Citer 3 bactéries qui peuvent être responsables de cette infection.

- 6. Quelle antibiothérapie de première intention prescrivez-vous chez ce patient (Molécules / doses / voies d'administration) ?**

- 7. En plus de l'antibiothérapie, citez 3 autres mesures thérapeutiques.**

- 8. Quels sont les deux examens d'imagerie à demander en première intention chez ce patient ?**

- 9. Citez 3 anomalies à rechercher sur ces 2 examens d'imagerie.**